アセスメント（課題分析）

・利用者：古賀 正蔵 様（U02）／男性／1947-01-22 生（79歳）

・実施日：2026-10-14（水）10:00〜10:50 実施場所: 自宅 面接相手: 本人、妻（照子様）

・実施者：真柴 洋子

・アセスメントの理由：退院（みずなら市民病院 2026-09-05〜10-12 肺炎で入院）に伴う再アセスメント

・前回：2026-01-21（認定更新時、自宅訪問）

■ 基本情報に関する項目

1. 基本情報: みずなら市ならの里在住。妻（77歳）と二人暮らし。長男は県外在住、月1回電話。

2. これまでの生活と現在の状況: 元郵便局員。2021 年に脳梗塞（左片麻痺軽度）。COPD で以前から息切れあり。9/5 肺炎で救急搬送され入院、10/12 退院。入院中に体力・歩行能力が低下。

3. 社会保障制度の利用情報: 介護保険、後期高齢者医療、厚生年金、身体障害者手帳なし。

4. 現在利用している支援や社会資源: 訪問介護（入浴介助）、通所リハ（入院により休止中）、福祉用具（特殊寝台・付属品）。

5. 日常生活自立度（障害）: B1（入院前 A2）

6. 日常生活自立度（認知症）: I

7. 主訴・意向: 本人「家に帰れてほっとした。また前のように歩けるようになりたい」。妻「夜に何かあったらと思うと不安。看護師さんに来てほしい」。

8. 認定情報: 要介護3、有効期間 2026-02-01〜2027-01-31。

9. 今回のアセスメントの理由: 退院に伴う状態変化。

■ 課題分析に関する項目

10. 健康状態: COPD、脳梗塞後遺症（左片麻痺軽度）、肺炎（治癒）。退院時 SpO2 94〜96%（室内気）、労作時 90% 前後に低下。かかりつけ医 くぬぎ台内科 久留島医師。在宅酸素の導入はなし。退院時に服薬変更あり（吸入薬の追加）。

11. ADL: 屋内移動は病棟で歩行器歩行を練習、自宅でも歩行器で移動（居間〜トイレ約8m）。歩行器なしでは左足の振り出しが不十分でふらつく。起き上がりは特殊寝台の背上げとベッド柵を使って自立。入浴は訪問介護で介助。更衣一部介助。

12. IADL: 家事は妻。服薬は吸入薬の手技が不安定で確認が必要。

13. 認知機能や判断能力: 年相応。

14. コミュニケーション: 問題なし。

15. 生活リズム: 退院後は日中も臥床がち（10〜15時に2時間程度）。

16. 排泄の状況: トイレで自立（歩行器使用）。夜間1回。

17. 清潔の保持: 入浴は訪問介護で週2回。息切れに注意。

18. 口腔内の状況: 自歯一部、義歯なし。

19. 食事摂取の状況: 入院中はとろみ食、退院時に常食へ戻る。むせ時々。体重 入院前 61kg → 57kg。

20. 社会との関わり: 通所リハで知人あり、再開を希望。

21. 家族等の状況: 妻が主介護者。夜間の急変への不安が強い。

22. 居住環境: 平屋持ち家。居間〜トイレの廊下は幅約80cm、段差なし。

23. その他留意すべき事項: 誤嚥性肺炎の再発に注意。

■ 課題の整理（ケアマネの判断）

・呼吸状態・服薬（吸入）の観察が必要で、妻の不安も強い → 訪問看護の導入（主治医の意見を照会）

・体力・歩行能力の低下 → 自宅内の安全な移動、通所リハの再開時期の検討
・入浴は訪問介護で継続
・起き上がり・立ち上がりのための特殊寝台は継続
・食事のむせ・体重減少の観察